



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : حنان محمد توفيق محمد

العنوان : 11 ش احمد هريدي

صفط اللبن بولاق الدكرور الجيزه

تاريخ تسجيل الإستمارة : 06-10-2026

المحافظة : الجيزه

رقم البطاقة : 28503202103062 رقم التليفون : 01000225950

العمر (تاريخ الميلاد) : 20-03-1985 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة

قسم العلاج :
الأورام

[11129]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني

الاسم : د/ندى حسن

الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة :

الوظيفة :

الوظيفة :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة

رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

قسم :

جهة العلاج :

نفقات :

ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: حنان محمد توفيق محمد National ID: 28503202103062	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



رسوم الاستعلام 20 جنية

جهة الاصدار : فرع الجيزة

تاريخ الاصدار : 2026-8-18

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسى " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى
والبحث تبين أن

السيد (ة) حنان محمد توفيق محمد بطاقة رقم 28503202103062

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفحة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة : 2026-8-18



افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،

مسلسل 2054511



الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لتنظم المعلومات و التحول الرقمى

اسم المريض بالإنجليزية: Hanan Mohamed Tawfik Mohamed	كرد المريض: 98578
تاريخ التقرير: 2026/08/19 11:24:30 AM	السن: ٤١ سنة, ٤ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral full field Digital Mammography

Clinical summary: Right breast lump sensation

Technique

Medio-lateral oblique and CC views & High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR B)
- An area of architectural distortion is noted in the upper outer quadrant it has linear extension extends from the middle to the posterior third of the breast measures about 8 cm in length
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated an area of heterogenous parenchyma (non mass lesion is noted occupying the region from 10 : 11 : 00 clock , in both zones B & C
- Multiple ipsilateral pathologically enlarged axillary lymph nodes are noted , they have focal cortical thickening that reaches up to 5 mm
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR B)
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

Right breast : BIRADS 4 C UOQ architectural distortion as described above, with associated ipsilateral suspicious looking axillary lymph nodes . true cut needle biopsy is done at the same setting

Left breast : BIRADS 1 , normal study

Dr. Hekmat Samir .md

عبدالله بن محمد
 ١٣/١٤٣٨ هـ



١١١١٩٢٢٦٤٧
 ١١/٢١.٥٥٨.٧



Patient Name	حسان محمد توفيق	Case No.	359400
Sex/Age	Female 41 Y	Patient No.	26153
Registered Date	20/8/2026 01:46:57 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	26/9/2026 12:15:18 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	30/9/2026 10:39:19 AM	Pathology No.	2683/26

Pathology Report

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 20/08/2026, at 10:30 am. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Six grey, white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive lobular carcinoma.
- Histologic grade: 2 (Differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1)
- LCIS: Present.
- Microcalcification: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 30% of tumor cells (score 6/8).
- Her2: Strong complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 3+).
- Ki67%: 40%.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive lobular carcinoma, Grade 2, with lobular carcinoma in situ.
- IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 6/8).
- Her2: Positive (score 3+).

ملاحظة
المرجع
المرجع
المرجع



Gustave Roussy International-Egypti- Pathology Lab
جوستاف روسي - مصر - مختبر أمراض الباثولوجي



Patient Name	حسان محمد توفيق	Case No.	359400
Sex/Age	Female 41 Y	Patient No.	26153
Registered Date	20/8/2026 01:46:57 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	26/9/2026 12:15:18 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	30/9/2026 10:39:19 AM	Pathology No.	2683/26

- Ki67%: 40%.

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature:

Dr. Walaa Ibrahim Chonaim, MD.

اسم المريض بالخطيرة: Hanan Mohamed Tawfik Mohamed	كود المريض: 98578
تاريخ الفحص: 2026/08/19 11:24:30 AM	اللقب: السيد، الأول: السيد

Women's Health Outreach Program Bilateral full field Digital Mammography

Clinical summary: Right breast lump sensation

Technique

Medio-lateral oblique and CC views & High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR B)
- An area of architectural distortion is noted in the upper outer quadrant it has linear extension extends from the middle to the posterior third of the breast measures about 8 cm in length
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated an area of heterogenous parenchyma (non mass lesion is noted occupying the region from 10 : 11 : 00 clock , in both zones B & C
- Multiple ipsilateral pathologically enlarged axillary lymph nodes are noted , they have focal cortical thickening that reaches up to 5 mm
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR B)
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

Right breast : BIRADS 4 C UOQ architectural distortion as described above, with associated ipsilateral suspicious looking axillary lymph nodes . true cut needle biopsy is done at the same setting

Left breast : BIRADS 1 , normal study

Dr. Hekmat Samir .md